

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE CAPACIDADES Y DIFICULTADES (SDQ)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Cribado Conductual, Emocional y Prosocial en la Infancia y Adolescencia

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ).
Nombre Original (Inglés)	<i>Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)</i>
Autor Original	Prof. Robert Goodman (1997, 2001), Institute of Psychiatry, King's College London.
Adaptaciones Españolas	Ortuño-Sierra et al. (2015, validación normativa nacional en Psicothema); Rodríguez-Hernández et al. (2012).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Cribado epidemiológico y clínico del desarrollo infanto-juvenil.
Tipo de Instrumento	Cuestionario multi-informante (autoinforme, padres y profesores) de 25 reactivos politómicos de 3 anclajes (0, 1 y 2).
Población y Rango	Niños y adolescentes de 4 a 17 años (versión autoinforme validada a partir de los 11 años).
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos.
Régimen de Licencia	Acceso abierto institucional (Youthinmind / SDQinfo) para uso clínico, escolar y de investigación sin fines de lucro.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO EQUILIBRADO DE FORTALEZAS

El SDQ fue diseñado por Robert Goodman (1997) con el propósito deliberado de superar el sesgo exclusivamente patologizante de escalas clásicas como el CBCL de Achenbach o el Cuestionario de Rutter. La aportación conceptual determinante del SDQ radica en su **enfoque equilibrado**, integrando tanto la evaluación de las dificultades psicopatológicas (internalizantes y externalizantes) como las **capacidades prosociales** y recursos de adaptación del menor.

El instrumento evalúa cinco dimensiones clínicas nucleares del desarrollo: **síntomas emocionales** (ansiedad y ánimo depresivo), **problemas de conducta** (oposicionismo y agresividad), **hiperactividad/inatención** (disfunción ejecutiva motora), **problemas con compañeros** (aislamiento social y victimización) y **conducta prosocial** (empatía y solidaridad). Esta doble mirada incrementa significativamente la receptividad de familias y docentes en cribados escolares y comunitarios.

3. SUBESCALAS DEL CUESTIONARIO SDQ (GOODMAN, 1997, 2001)

Subescala SDQ	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Significación Clínica
1. Síntomas Emocionales	3, 8, 13, 16, 24	0 a 10	Dolores somáticos frecuentes, preocupaciones, tristeza, llanto, temores y falta de confianza.
2. Problemas de Conducta	5, 7, 12, 18, 22	0 a 10	Rabietas desmedidas, discusiones con adultos, peleas, mentiras, trampas y hurtos.
3. Hiperactividad	2, 10, 15, 21, 25	0 a 10	Inquietud motora, levantarse, distractibilidad, falta de perseverancia e impulsividad reflexiva.
4. Problemas con Compañeros	6, 11, 14, 19, 23	0 a 10	Tendencia al aislamiento, falta de amigos íntimos, burlas sufridas y mala relación con iguales.
5. Conducta Prosocial	1, 4, 9, 17, 20	0 a 10	Consideración hacia los demás, compartir cosas, ayudar a quien sufre y ser amable con los pequeños.
TOTAL DE DIFICULTADES	Ítems 1 al 20	0 a 40	Suma de las 4 primeras subescalas (excluye Conducta Prosocial).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach de 0.84 a 0.88 para la Puntuación Total de Dificultades en muestras comunitarias y clínicas españolas (Ortuño-Sierra et al., 2015; Rodríguez-Hernández et al., 2012).
Sensibilidad y Especificidad	Para el punto de corte clínico <i>ge20</i> en el Total de Dificultades: sensibilidad del 85% y especificidad del 88% frente a diagnósticos DSM de trastornos infantojuveniles.
Validez Concurrente	Correlación elevada con las escalas correspondientes del CBCL de Achenbach ($r = 0.78$) y con el Cuestionario BASC ($r = 0.74$).
Validez Discriminante	Diferencia de manera estadísticamente nítida entre menores en seguimiento psiquiátrico ambulatorio y población escolar normativa.
Invarianza de Medida	Invarianza factorial confirmatoria rigurosa comprobada por sexo y niveles educativos en adolescentes españoles.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN E INVERSIÓN DE ÍTEMS

Cada afirmación se valora en función del comportamiento en los **últimos 6 meses**:

- **Ítems Directos:** **0** = No es verdad | **1** = Un poco verdad | **2** = Absolutamente verdad.
- **Inversión de Ítems Positivos:** Los ítems **7, 11, 14, 21 y 25** se puntúan a la inversa ($0 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 0$) antes del cómputo.
- **Puntuación Total de Dificultades:** Suma de las 4 subescalas de problemas (Emocional + Conducta + Hiperactividad + Compañeros). Rango: **0 a 40 puntos**.

Total Dificultades = 0 a 40 pts | Conducta Prosocial = 0 a 10 pts (Se interpreta por separado)

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN NORMATIVA (ORTUÑO-SIERRA ET AL., 2015; GOODMAN, 2001)

Estrato	Puntuación	Estado del Desarrollo	Conducta Asistencial Recomendada
Normal	0 a 15	Desarrollo socioemocional adaptativo	Poco probable la presencia de patología psiquiátrica. Autocuidado y apoyo educativo habitual.
Limítrofe	16 a 19	Zona de riesgo / Dificultades moderadas	Dificultades emocionales o de conducta notables. Intervención orientadora y seguimiento escolar.
Anormal	20 a 40	Corte Positivo (Patología Significativa)	Alta probabilidad de trastorno clínico formal. Derivación prioritaria a Salud Mental Infanto-Juvenil.

BAREMOS DE LA SUBESCALA PROSOCIAL (FACTOR PROTECTOR): En Conducta Prosocial (0 a 10), una puntuación de **8 a 10** es Normal, **7** es Limítrofe y **0 a 6** es Clínicamente Anormal (indica frialdad afectiva o desconexión empática grave, correlacionando con rasgos de insensibilidad emocional).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y MULTI-INFORMANTE

TRIANGULACIÓN INFORMANTE Y ACCIÓN ASISTENCIAL:

- **Paso 1 (Cotejo de Informantes):** Contrastar las puntuaciones de padres, docentes y el autoinforme del menor. La discrepancia entre colegio y hogar aporta claves etiológicas fundamentales sobre las contingencias ambientales.
- **Paso 2 (Perfil Internalizante vs. Externalizante):** Si predominan las subescalas Emocional y Compañeros, orientar hacia trastornos de ansiedad, depresión o acoso escolar. Si predominan Conducta e Hiperactividad, evaluar TDAH y negativismo desafiante.
- **Paso 3 (Análisis del Factor Prosocial):** Puntuaciones prosociales conservadas (*ge8*) constituyen el pilar fundamental para intervenciones de aprendizaje cooperativo y resiliencia vincular.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN ESCOLAR DE 12 AÑOS

Paciente: Varón de 12 años, remitido por el orientador escolar de 1.º de ESO debido a aislamiento progresivo en los recreos, somatizaciones recurrentes con cefaleas antes de ir al colegio y descenso del rendimiento.

Resultados SDQ (Autoinforme):

- **Puntuación Total de Dificultades: 23/40 (Rango Anormal — Clínicamente Significativo).**
- **Desglose por subescalas:** Síntomas Emocionales = **8/10** (muchas preocupaciones, dolor de estómago matutino y tristeza); Problemas con Compañeros = **7/10** (burlas constantes, preferencia por estar solo en el patio); Hiperactividad = 4/10; Problemas de Conducta = 4/10; Conducta Prosocial = 9/10 (altamente empático y colaborador).

Conducta Asistencial: Se diagnostica Trastorno de Ansiedad Social reactivo a situación de victimización escolar encubierta (bullying relacional). Se activa de inmediato el protocolo de acoso escolar en el centro educativo, garantizando acompañamiento tutelado en los patios. En psicoterapia individual se aplican técnicas cognitivas de manejo de la ansiedad y entrenamiento en asertividad. A los 4 meses, las Dificultades Totales bajaron a 11/40 (rango normal), integrándose satisfactoriamente en un club deportivo escolar.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA

ALERTA: SÍNTOMAS EMOCIONALES *ge7*

Puntuaciones máximas en la subescala emocional con quejas somáticas y tristeza exigen exploración urgente de ideación autolítica y conductas autole-sivas mediante entrevista clínica directa.

PROBLEMAS CON COMPAÑEROS *ge6*

Puntuaciones elevadas en la subescala de compañeros obligan al clínico a descartar de forma proactiva la presencia de victimización por acoso escolar (*bullying*) o ciberacoso.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 38(5), 581–586.
2. Goodman, R. (2001). Psychometric properties of the strengths and difficulties questionnaire. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 40(11), 1337–1345.
3. Ortuño-Sierra, J., Chocarro, E., Fonseca-Pedrero, E., Rivas, S., & Muñiz, J. (2015). The Strengths and Difficulties Questionnaire: Psychometric properties and normative data for Spanish adolescents. *Psicothema*, 27(1), 76–83.
4. Rodríguez-Hernández, P. J., et al. (2012). Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ): validación en una muestra española. *Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil*, 29(1), 35–44.